

# Salute Mentale — Panoramica completa

Semestre 02 · 10 lezioni

Un viaggio che parte dalle definizioni base (cos'è salute, malattia, normalità) e arriva al cuore della clinica: come si guarda, si ascolta, si comprende chi soffre. In mezzo: la storia della follia, le emozioni, le difese, i quadri clinici maggiori — dalle nevrosi ai disturbi di personalità fino alle psicosi. Il filo rosso è sempre lo stesso: l'incontro tra due persone, non la classificazione di un oggetto.

## Mappa dei temi

| #  | Lezione                      | Tema centrale                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 01 | Intro al modulo              | Salute, benessere, normalità, cura vs. guarigione   |
| 02 | Storia della follia          | Paradigmi storici: organico vs. passionale          |
| 03 | Le empatie                   | Empatia come costrutto multi-componente e evolutivo |
| 04 | Dalla paura alle difese      | Filiera emotiva e meccanismi di difesa              |
| 05 | Dispercepire il mondo        | Semiologia, funzioni cognitive, psicofarmaci        |
| 06 | Sindromi affettive e ansiose | Depressioni, bipolari, disturbi d'ansia             |
| 07 | Le nevrosi                   | DOC e isteria: conflitto egodistonico               |
| 08 | I disturbi di personalità    | Struttura del carattere, cluster A/B/C, BPD         |
| 09 | Le psicosi                   | Schizofrenia, psicosi organiche e funzionali        |

| #  | Lezione           | Tema centrale                                                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10 | Il corpo sessuato | Sessualità, identità di genere, parafilie, disforia di genere |

## Cornice concettuale: salute, malattia, normalità

Il modulo si apre definendo i termini che stanno alla base di tutto il resto.

- **Salute** → 7 condizioni di **Boorse** (1977): valore, trattamento medico, norma statistica, sofferenza, disabilità, adattamento, omeostasi · nessuna sufficiente da sola · (Lez. 01)
- **Disease / Illness / Sickness** → dimensione biomedica, soggettiva, sociale · possono non coincidere · lo stigma peggiora il decorso · (Lez. 01)
- **Benessere** → 6 dimensioni di **Ryff**: autonomia, controllo ambientale, relazioni positive, autoaccettazione, crescita, scopo · salute ≠ benessere · (Lez. 01)
- **Normalità** → statistica · di valore · personale · ogni tipo ha il suo rischio di stigma o sofferenza · (Lez. 01)
- **To cure vs. to care** → guarire non sempre possibile, curare sì · *"Non tutto si può guarire, ma tutto può essere curato"* · (Lez. 01)
- **Posizione del soggetto** → agente/passivo × identificato/non identificato con la malattia · (Lez. 01)
- **Patologia vs. normalità** → 3 criteri: durata, intensità, compromissione · (Lez. 07)

## I due paradigmi della follia

Tema centrale in Lez. 02, riecheggia in tutte le altre.

- **Gehirnpsychiatrie** → follia = malattia organica del cervello (Donizetti, sifilide) · (Lez. 02)
- **Geistespsychiatrie** → follia = passioni, traumi, vita (Lucia di Lammermoor) · (Lez. 02)

- **Comprensibilità (Jaspers)** → follia passionale comprensibile · follia organica incomprensibile · (Lez. 02)
  - **Somatiker vs. Psychiker** → declinazione ottocentesca del dualismo (Griesinger) · (Lez. 02)
  - **Alienazione** → essere "altrove", fuori dal proprio mondo · (Lez. 02)
  - **Avere vs. essere la malattia** → non-identificazione vs. identificazione identitaria → paradigmi di cura diversi · (Lez. 01, 02)
  - **Nevrosi** nasce qui (Cullen, 1777) e riemerge come tema centrale in Lez. 07
  - **Psicosi organiche vs. funzionali** → distinzione già implicita nei due paradigmi; sistematizzata in Lez. 09 (Minkowski): organiche = struttura io–qui–adesso crollata; funzionali = struttura intatta ma dissociata · (Lez. 09)
- 

## Evoluzione storica della psichiatria

- **Grecia** → **Ippocrate** → emancipazione dalla religione · teoria degli umori · fluidisti · (Lez. 02)
  - **Medioevo** → religione domina; nessuna novità · (Lez. 02)
  - **1500–1700** → rinascita scientifica · "Homme machine" · nevrosi (Cullen) · nevrastenia (Beard) · (Lez. 02)
  - **Pinel** → Bicêtre 1793 · **guaribilità, patoplastica, parzialità della follia, trattamento morale** · (Lez. 02, ripreso in Lez. 07)
  - **Esquirol** → passionale curabile vs. organica incurabile · idiozia vs. demenza · (Lez. 02)
  - **Positivismo XIX sec.** → Griesinger · Morel (degenerazione, delirio paranoico) · Lombroso (atavismo) · Krafft-Ebing · (Lez. 02)
  - **Kraepelin** → nosologia · endogene/esogene · psicosi maniaco-depressiva vs. demenza precoce · (Lez. 02, base per Lez. 06, 09)
  - **Bleuler 1911** → schizofrenia · sintomi primari/ secondari · recupera la patoplastica · (Lez. 02, 09)
  - **Charcot** → **Freud** → passaggio dall'ipnosi alla dinamica inconscia · (Lez. 07)
  - **DSM-III in poi** → abbandono del termine "nevrosi", frammentazione in diagnosi specifiche · (Lez. 07)
-

# Emozioni: filiera, paura, ansia, umore

Lez. 04 e Lez. 06 condividono tutta la filiera emotiva.

- **Emozione** → reattiva, acuta, con oggetto (Galimberti) · **Umore** → disposizione di fondo (Delay) · (Lez. 06)
  - **Emozioni di base** → Ekman & Friesen (6) · Plutchik (8 + fiore: intensità, attenuazione, combinazioni) · (Lez. 06)
  - **Filiera della paura** → minaccia → valutazione protocognitiva → paura → fuga / attacco / mimetismo · (Lez. 04)
  - **Paura vs. ansia** → oggetto presente (amigdala) vs. futuro ipotetico (BNST) · ansia = paura + anticipazione (Plutchik) · (Lez. 04, 06)
  - **Freezing** → intensità eccessiva supera soglia di arousal · (Lez. 04)
  - **Ansia normale vs. patologica** (Biondi) · **ansia di stato vs. di tratto** (Sims & Snaith) · (Lez. 04, 06)
  - **Rimuginio ansioso vs. ruminazione depressiva** → futuro vs. passato · alimenta ansia vs. prolunga depressione · (Lez. 06)
  - **Sorpresa · Angoscia** → angoscia reale = paura; angoscia nevrotica = ansia (Freud) · (Lez. 04)
  - **Fonti di angoscia (Freud 1930)** → corpo · natura · relazioni (porcospini di Schopenhauer) · (Lez. 04)
- 

## Meccanismi di difesa e struttura della personalità

Ponte tra Lez. 04 (classificazione), Lez. 07 (nevrosi), Lez. 08 (disturbi di personalità) e Lez. 09 (psicosi).

- **MDD** → risposta automatica, inconscia, dell'Io contro l'angoscia (≠ coping) · (Lez. 04)
- **3 criteri Anna Freud** → age adequateness · intensity · balance · (Lez. 04)

- **Primitivi** → ritiro · diniego · proiezione · introiezione · identificazione proiettiva · scissione · idealizzazione · svalutazione · controllo onnipotente · (Lez. 04)
    - Dominanti nel **cluster A e B** dei disturbi di personalità e nella struttura borderline (Lez. 08)
  - **Maturi / secondari** → rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · capovolgimento · isolamento affetti · intellettualizzazione · razionalizzazione · moralizzazione · compartimentalizzazione · umorismo · (Lez. 04)
  - **Scala di Perrotta (adatt. Pezzoli)** → 7 livelli da rottura con la realtà a difese mature · (Lez. 04)
  - **Angosce per area clinica** → nevrosi = castrazione · psicosi = frammentazione · borderline = abbandono · (Lez. 04, ripresa in Lez. 07, 08, 09)
  - **Struttura nevrotica (Bergeret)** → Super-Io dominante · conflitto edipico · difesa = rimozione · relazione genitale · diagnosi solo da adulti · (Lez. 07)
  - **Linea di divisione (Abraham)** → sotto-stadio anale evacuazione (psicotico) / ritenzione (nevrotico) · (Lez. 07)
  - **Difese nel DOC** → rimozione · formazione reattiva · spostamento · isolamento · annullamento retroattivo · tutte già viste in Lez. 04 · (Lez. 07)
  - **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → struttura nevrotica / borderline / psicotica · identità, difese, esame di realtà come tre assi diagnostici · (Lez. 08)
- 

## Empatia e relazione di cura

- **Einfühlung** → "sentire dentro" · Lipps (1905) · (Lez. 03)
- **Critica del "mettersi nei panni"** → stare accanto, non al posto dell'altro (Ricoeur, Pezzoli) · (Lez. 03)
- **Simulazione incarnata** → Gallese · neuroni specchio · automatica, pre-riflessiva · (Lez. 03)
- **Modello Feshbach** → 3 componenti: assunzione di prospettiva · decodifica emotiva · risonanza · TOM (Wellman: DD/DB/KA/FB/HE) · preconditione sé/altro · (Lez. 03)

- **Modello Hoffman** → empatie al plurale · evolutive · motivazionali · 5 stadi dal distress globale all'empatia oltre la situazione · (Lez. 03)
  - **Contagio emotivo** → imitazione motoria (Ekman 1992) · reazione circolare primaria · (Lez. 03)
  - **Empatia / simpatia / compassione** → feeling with vs. feeling for (Singer & Klimecki) · (Lez. 03)
  - **6 bias empatici (Pezzoli)** → similarità · giudizio morale · inganno/invidia · insensibilità numerica · non rende più buoni · faticosa · → burnout · (Lez. 03)
  - **Empatia egocentrica** → aiutare con ciò che consola sé: la "lezione 3" del mito di Medusa riprende il tema · (Lez. 03, 04)
  - **To care** come cura sempre possibile si poggia sull'empatia matura · (Lez. 01, 03)
- 

## Semiologia: come si guarda il paziente

Lez. 05 è la cassetta degli attrezzi clinici.

- **Segni vs. sintomi** → oggettivi / soggettivi · (Lez. 05)
- **Semiologia del comportamento** → apparenza (ipertimia, amimia, mimica discordante) · discorso · condotte istintuali · passaggi all'atto · funzioni psicomotorie (catatonia, tic, stereotipie) · (Lez. 05)
- **Semiologia dello stato mentale** →
  - **Coscienza** → quantitative (lucidità → coma) / qualitative (delirium, oniroide, crepuscolare, mania à potu) · (Lez. 05)
  - **Orientamento** → tempo, spazio, persona · persona alterata = massima gravità · (Lez. 05)
  - **Memoria** → sensoriale, breve, lavoro, lungo termine · disturbi quantitativi (amnesie, ipo/ipermnesia) e qualitativi (confabulazioni, déjà vu) · (Lez. 05)
  - **Attenzione** → selettiva, divisa, sostenuta · (Lez. 05)
  - **Percezione** → sensazione vs. percezione · illusione vs. allucinazione · agnosie, prosopagnosia, anosognosia · (Lez. 05)
- **Funzioni cognitive** → memoria, attenzione, esecutive, linguaggio, prassie, gnosis, emozioni · (Lez. 05)

- **Neurotrasmettitori** → dopamina, serotonina, noradrenalina, GABA, glutammato, acetilcolina · (Lez. 05)
- 

## Quadri clinici maggiori

### Sindromi affettive (Lez. 06)

- **Nucleo depressivo comune (Klein)** → umore depresso · rallentamento psicomotorio e psichico · anedonia · apatia · alfa privativo
- **Classificazione Lalli (2002)** → primarie (carattere depressivo) vs. secondarie (organiche)
- **Tre gruppi clinici** → psicogene (vittima, reattivo) · endogene (colpevole, non reattivo) · somatiche
- **DSM-5-TR** → disturbo depressivo maggiore ( $\geq 2$  sett.) · persistente ( $\geq 2$  anni) · depressione mascherata ( $\neq$  ipocondria)
- **Disturbi bipolari** → pendolo timico · bipolare I / II / ciclotimico · episodio maniacale (insonnia senza stanchezza, fuga di idee, perdita contatto con realtà) · ⚠ no antidepressivi in solitaria
- **Terapia** → stabilizzatori · litio (monitoraggio ematico) · psicoeducazione

### Sindromi ansiose (Lez. 06)

- **Sintomi** → cognitivi, affettivi, fisiologici, comportamentali
- **Disturbi d'ansia DSM-5-TR** → DAG (rimuginio) · ansia sociale (vergogna) · panico · agorafobia · fobia specifica · ansia da separazione · mutismo selettivo
- **Attacco di panico** → picco in pochi minuti ·  $\geq 4$  su 13 sintomi · accoglienza senza giudizio
- **DOC e PTSD** → non più nei disturbi d'ansia nel DSM-5-TR

### Nevrosi (Lez. 07)

- **Definizione** → disturbo psichico senza causa organica · conflitto desiderio/regola non risolto → sintomo · non è malattia
- **Sintomo egodistonico** (nevrosi) vs. **egosintonico** (disturbi personalità) → consapevolezza, sofferenza, richiesta di aiuto

- **Fenomenologia** → bassa autostima, colpa, vergogna · ansia dominante · sintomi somatici · esame di realtà mantenuto (≠ psicosi)
- **DOC** → luogo del sintomo = pensiero · ossessioni (non desiderate, incongruenti, si resiste) · compulsioni (solievo ≠ piacere) · evitamento
- **Isteria** → luogo del sintomo = corpo · hystéra = utero · Ippocrate → Charcot (4 fasi) → Freud · **conversione** del conflitto sul piano somatico · isterica di conversione vs. d'angoscia (fobia, spostamento)
- **Nel DSM-5-TR** → le nevrosi classiche si sono frammentate in disturbi d'ansia, DOC, traumatici, somatici, dissociativi

## Disturbi di personalità (Lez. 08)

- **Personalità** → temperamento (biologico, congenito) + carattere (acquisito) = modalità stabili di pensare · sentire · comportarsi · relazionarsi
- **Tratto vs. stato** → tratto = stabile (base dei disturbi di personalità) · stato = temporaneo (base delle sindromi cliniche come la depressione maggiore)
- **Da stile a disturbo** → tratti rigidi e pervasivi → sofferenza e/o compromissione · modello bio-psico-sociale (Paris): diatesi + stress = disturbo
- **Egosintonia** → tratti non percepiti come problematici → scarsa motivazione al trattamento
- **Spettro internalizzante vs. esternalizzante** → soffrono dentro (evitante, dipendente, schizoide) vs. fanno soffrire gli altri (paranoide, narcisistico, antisociale) · BPD oscilla tra i due
- **Cluster A** — strani ed eccentrici:
  - **Paranoide** → diffidenza pervasiva · difese: proiezione, identificazione proiettiva
  - **Schizoide** → distacco relazionale · difesa: ritiro
  - **Schizotipico** → distorsioni cognitive/percettive · più vicino alla psicosi
- **Cluster B** — drammatici, emotivi, imprevedibili:
  - **Antisociale** → violazione diritti altrui · criterio: disturbo della condotta prima dei 15 anni
  - **Borderline (BPD)** → instabilità relazioni/identità/umore · scissione · angoscia di abbandono · suicidalità in 80% dei ricoverati · ~20% dei pazienti psichiatrici (Gunderson) · difese: scissione, identificazione proiettiva, dissociazione, acting out



- **Istrionico** → emotività eccessiva, ricerca attenzione
- **Narcisistico** → grandiosità, mancanza empatia emotiva · difese: idealizzazione, svalutazione
- **Cluster C** — ansiosi e inibiti:
  - **Evitante** → inibizione sociale · vuole le relazioni ≠ schizoide
  - **Dipendente** → bisogno pervasivo di accudimento
  - **DOCP** → ordine e controllo · egosintonico ≠ DOC
- **Organizzazione di personalità (Kernberg)** → nevrotica / borderline / psicotica: differiscono per identità, difese, esame di realtà · (Lez. 08)
- **Trattamenti validati per BPD** → DBT (Linehan) · MBT · TFP (Kernberg)
- **Problema diagnostico** → DSM categoriale ↔ psicopatologia dimensionale · PDM-2 (Lingiardi & McWilliams) come alternativa

## Psicosi (Lez. 09)

- **Definizione** → rapporto radicalmente alterato con la realtà · due destrutturazioni (Jervis): realtà esterna + identità interna
- **Psicosi organiche** → causa biologica nota · io–qui–adesso crollato:
  - **Demenze** → Alzheimer, senile, acquisite (alcol, sifilide)
  - **Epilessia** → grande male (tonica → clonica → risolutiva) · piccolo male (assenza breve, senza convulsioni) · crisi parziali
  - **Psicosi da sostanze** → sistema mesolimbico/dopamina · delirium tremens (astinenza alcolica) · Korsakov (amnesia anterograda cronica) · cannabis indoor (THC alto → rischio psicotico)
- **Psicosi funzionali** → causa multifattoriale · struttura io–qui–adesso intatta ma dissociata (sa ma non si sente)
- **Sintomatologia comune** → sintomi positivi (delirio + allucinazioni) · negativi (apatia, abulia, ritiro) · disorganizzazione cognitiva
- **Schizofrenia** → Bleuler 1911 · *schizein* + *phren* · orchestra senza direttore · sindrome fondamentale:
  - **Dissociazione** intellettuale (disorganizzazione, impoverimento, concretismo, tangenzialità, deragliamento) · affettiva (appiattimento, discordanza, ambivalenza) · psicomotoria (riduzione, agitazione, crisi pantoclastica, manierismi)
  - **Autismo schizofrenico** → perdita del contatto vitale con la realtà

- **Delirio** → convinzione falsa, incrollabile, non riducibile alla logica (Sims) · contenuti: persecuzione, grandiosità, influenzamento...
  - **Depersonalizzazione / Derealizzazione** → sé come automa · mondo come estraneo · tempo cristallizzato
  - **Allucinazioni** → prevalentemente uditive · indistinguibili dal reale · ⚠ voci perentorie con ordini pericolosi
  - **Tipo 1 vs. Tipo 2 (Crow, 1980)** → positivi/reversibili vs. negativi/cronici
  - **Decorso** → premorbo → prodromico → stato (~20 anni) → esiti · ⚠ picco suicidalità nel miglioramento, non nello scompenso
  - **Fattori prognostici** → favorevoli: diagnosi precoce, buon funzionamento premorbo, sesso femminile, rete sociale · sfavorevoli: esordio precoce, familiarità, sintomi negativi dominanti
- 

## Psicofarmacologia (Lez. 05)

- **Emivita · farmacodinamica · farmacocinetica** → base
  - **Antipsicotici** → tipici (1952) vs. atipici (anni '90) · sintomi positivi
  - **Antidepressivi** → bifasici · rischio suicidale prime settimane
  - **Ansiolitici** → benzodiazepine: effetto immediato, dipendenza
  - **Stabilizzatori** → litio, monitoraggio ematico
  - ⚠ Non dedurre la diagnosi dalla terapia · ⚠ terapia sempre integrata
- 

## Il corpo sessuato (Lez. 10)

- **Definizione OMS** → sessualità = aspetto centrale dell'essere umano per l'intero arco della vita · include sesso, identità di genere, orientamento, erotismo, piacere, intimità, riproduzione · (Lez. 10)
- **Galimberti** → sessualità come sviluppo psicologico e relazionale · parte dalla relazione madre-bambino · va oltre la riproduzione: simbolizzazione, sublimazione · (Lez. 10)
- **Körper vs. Leib (Husserl)** → corpo-oggetto anatomico vs. corpo vissuto relazionale · nelle parafilie il corpo altrui è vissuto come *Körper* · (Lez. 10)

- **Finalità della sessualità (Grazzottin)** → amorosa · ricreativa · procreativa · strumentale (disfunzionale se causa danno) · (Lez. 10)
- **Identità sessuale: 4 dimensioni** →
  - **Sesso biologico** → caratteristiche fisiche alla nascita (AFAB / AMAB / intersex ~1,7%)
  - **Identità di genere** → sensazione intima di sé (cisgender · transgender · gender fluid · agender)
  - **Ruolo di genere** → aspettative socioculturali
  - **Orientamento sessuale** → direzione dell'attrazione · (Lez. 10)
- **Bisogno vs. desiderio** → bisogno = immediato, non differibile · desiderio = differibile, passaggio evolutivo sano · bisogno non superato → compulsività → base delle parafilie · (Lez. 10)
- **6 snodi di Lalli** → umanizzazione · dipendenza→autonomia · bisogno→desiderio · riconoscimento reciproco · fantasia · rapporto con l'altro · ogni snodo ha versione sana e versione patologica · (Lez. 10)
- **DSM-5-TR: 3 categorie** → disfunzioni sessuali · disforia di genere · disturbi parafilici · (Lez. 10)
- **Disforia di genere** → focus sulla sofferenza, non sulla condizione · transgender ≠ disforia (non tutti i trans soffrono) · diagnosi necessaria per terapia ormonale/chirurgica · criteri: A (incongruenza ≥ 6 mesi) + B (sofferenza clinicamente significativa) · (Lez. 10)
- **Parafilìa vs. disturbo parafilico** → parafilìa = interesse intenso/persistente non convenzionale · disturbo = parafilìa + disagio personale o danno a sé/altri · parafilìa = condizione necessaria ma non sufficiente · (Lez. 10)
- **8 disturbi parafilici (DSM-5)** → voyeuristico · esibizionistico · pedofilico · feticcistico · da travestitismo · da masochismo sessuale (variante: asfissiofilia) · da sadismo sessuale · frotteuristico · (Lez. 10)

## Dimensione identitaria e incontro clinico

Filo che attraversa tutto il modulo.

- **4 dimensioni trasversali** → spazio · tempo · identità · incontro · (Lez. 01)

- **Crisi identitaria della follia** → chi sono? dove sono? in che tempo vivo? · vocabolario spaziale popolare · (Lez. 02)
- **Cargnello** → ambiguità irriducibile della psichiatria: "essere con qualcuno" vs. "avere qualcosa di fronte" · clinica = incontro · (Lez. 02)
- **Operatore sociale** → trait d'union tra discipline specialistiche · (Lez. 01)
- **Mito di Medusa (Ovidio)** → i "mostri" sono spesso vittime trasformate da ciò che hanno subito · (Lez. 04)
- **Diffusione dell'identità (Kernberg)** → il sé e gli altri poco integrati come tratto centrale dell'organizzazione borderline e psicotica · (Lez. 08)
- **Depersonalizzazione/derealizzazione** → il sé come automa, il tempo cristallizzato → la crisi identitaria al suo grado più estremo nella psicosi · (Lez. 09)

---

## Autori e riferimenti principali

| Chi        | Contributo                                                              | Lezione |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Boorse     | 7 condizioni della salute (1977)                                        | 01      |
| Ryff       | 6 dimensioni del benessere                                              | 01      |
| Callieri   | Definizione di clinica (1999)                                           | 01      |
| Guidorizzi | Follia nella tragedia greca (2010)                                      | 01      |
| Ippocrate  | Teoria degli umori; emancipazione dalla religione                       | 02      |
| Empedocle  | Equilibrio tra poli contrari                                            | 02      |
| Pinel      | Trattamento morale; Bicêtre 1793; guaribilità, patoplastica, parzialità | 02, 07  |
| Esquirol   | Follia passionale vs. organica; idiozia vs. demenza                     | 02      |
| Cullen     | Conia "nevrosi" (1777)                                                  | 02, 07  |
| Beard      | Nevrastenia                                                             | 02      |

| <b>Chi</b> | <b>Contributo</b>                                                               | <b>Lezione</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Griesinger | Follia = malattia del cervello; Somatiker/<br>Psychiker                         | 02             |
| Morel      | Degenerazione; demenza precoce;<br>alienazione mentale                          | 02, 09         |
| Lombroso   | Antropologia criminale; atavismo                                                | 02             |
| Kraepelin  | Nosologia endogene/esogene; psicosi<br>MD; demenza precoce                      | 02, 09         |
| Bleuler    | Schizofrenia (1911); sintomi primari/<br>secondari; gruppo delle schizofrenie   | 02, 09         |
| Jaspers    | Comprensibilità vs. incomprendibilità                                           | 02             |
| Cargnello  | Ambiguità della psichiatria; clinica come<br>incontro                           | 02             |
| Charcot    | Isteria; ipnosi; Salpêtrière                                                    | 07             |
| Freud      | Difese (1894); disagio della civiltà (1930);<br>dinamica inconscia; conversione | 04, 07         |
| Anna Freud | L'Io e i meccanismi di difesa (1936); 3<br>criteri                              | 04             |
| Klein      | Posizione schizoide/depressiva; nucleo<br>semiologico depressioni               | 04, 06         |
| Abraham    | Linea di divisione nevrotico/psicotico                                          | 07             |
| Bergeret   | Struttura nevrotica/psicotica; scompenso                                        | 07             |
| McWilliams | Tipologie di personalità; "nevrotico" =<br>alto livello di funzionamento        | 07, 08         |
| Lipps      | Einfühlung (1905)                                                               | 03             |
| Feshbach   | Modello multidimensionale dell'empatia                                          | 03             |

| <b>Chi</b>               | <b>Contributo</b>                                                      | <b>Lezione</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hoffman                  | Empatie al plurale; modello evolutivo                                  | 03             |
| Gallese                  | Simulazione incarnata; neuroni specchio                                | 03             |
| Tisseron                 | Empatia intersoggettiva; verso sé stessi                               | 03             |
| Bloom                    | Contro l'empatia; bias                                                 | 03             |
| Singer & Klimecki        | Compassione = feeling for                                              | 03             |
| Pezzoli                  | 6 bias empatici; schema contesto × minaccia                            | 03, 04         |
| Ekman & Friesen          | 6 emozioni di base (1971)                                              | 04, 06         |
| Plutchik                 | Modello multidimensionale; fiore delle emozioni                        | 04, 06         |
| Galimberti / Delay       | Definizioni di emozione / umore                                        | 06             |
| Lalli                    | Depressioni primarie vs. secondarie (2002)                             | 06             |
| Sims & Snaith            | Ansia di stato vs. di tratto                                           | 06             |
| Biondi                   | Ansia normale vs. patologica                                           | 04             |
| Grillon                  | Amigdala (paura) vs. BNST (ansia)                                      | 04             |
| Perrotta                 | Scala potenziale disadattivo dei MDD (2020)                            | 04             |
| Schopenhauer             | Porcospini → distanza relazionale                                      | 04             |
| Ovidio                   | Metamorfosi; mito di Medusa                                            | 04             |
| Thomas, Chess & Birch    | 9 variabili temperamentali; bambini facili/difficili/lenta attivazione | 08             |
| Eysenck / Costa & McCrae | Modelli di tratti (Big Five)                                           | 08             |

| Chi                                                 | Contributo                                                                        | Lezione    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Reich                                               | Corazza caratteriale                                                              | 08         |
| Paris                                               | Modello bio-psico-sociale dei disturbi di personalità (1997)                      | 08         |
| Gunderson & Links                                   | BPD = ~20% dei pazienti psichiatrici                                              | 08         |
| Linehan                                             | DBT; BPD come "ustioni di terzo grado"                                            | 08         |
| Kernberg                                            | Organizzazione borderline/nevrotica/psicotica; TFP                                | 08         |
| Lingiardi & McWilliams                              | PDM-2; approccio dimensionale e psicodinamico                                     | 08         |
| Minkowski                                           | Triade io–qui–adesso; psicosi organiche vs. funzionali                            | 09         |
| Jervis                                              | Due destrutturazioni centrali nella psicosi                                       | 09         |
| Crow                                                | Tipo 1 (positivi) / Tipo 2 (negativi) della schizofrenia (1980)                   | 09         |
| Stanghellini & Ballerini                            | Vulnerabilità premorbosa; identikit del futuro paziente                           | 09         |
| APA                                                 | DSM-5-TR (2023)                                                                   | 06, 07, 08 |
| Pewzner / Sims /<br>Baddeley / Faravelli /<br>Stahl | Semiologia, memoria, psicofarmaci                                                 | 05         |
| Husserl                                             | Körper vs. Leib — corpo-oggetto vs. corpo vissuto                                 | 10         |
| Krafft-Ebing                                        | <i>Psychopathia Sexualis</i> — primo catalogo scientifico della sessualità (1886) | 02, 10     |
| Kinsey                                              |                                                                                   | 10         |

| Chi               | Contributo                                                                                 | Lezione |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                   | Rapporto Kinsey — studio comportamentale su 18.000 persone                                 |         |
| Masters & Johnson | <i>Human Sexual Response</i> — ciclo della risposta sessuale (1966)                        | 10      |
| Grazzottin        | Tassonomia delle finalità della sessualità (amorosa, ricreativa, procreativa, strumentale) | 10      |
| Lalli             | 6 snodi dello sviluppo psicosessuale                                                       | 10      |

## Parole chiave della materia

salute · benessere · normalità · disease · illness · sickness · to cure · to care · agentività · clinica · Gehirnpsychiatrie · Geistespsychiatrie · Somatiker · Psychiker · teoria degli umori · trattamento morale · patoplastica · parzialità della follia · degenerazione · nosologia · schizofrenia · psicosi maniaco-depressiva · alienazione · comprensibilità · pellagra · Einfühlung · empatia cognitiva · empatia affettiva · simulazione incarnata · neuroni specchio · Theory of Mind · decentramento · compassione · bias empatico · sovrattivazione empatica · paura · ansia · angoscia · freezing · arousal · amigdala · BNST · filiera emotiva · meccanismi di difesa · ritiro primitivo · diniego · proiezione · scissione · idealizzazione · rimozione · dissociazione · formazione reattiva · spostamento · isolamento affetti · intellettualizzazione · umorismo · angoscia di castrazione · angoscia di frammentazione · angoscia di abbandono · semiologia · segni · sintomi · catatonia · coscienza · orientamento · amnesia · confabulazione · illusione · allucinazione · agnosia · anosognosia · farmacodinamica · farmacocinetica · antipsicotici · antidepressivi · ansiolitici · stabilizzatori · litio · emozione · umore · eutimia · anedonia ·



apatia · alfa privativo · pendolo timico · depressione  
mascherata · bipolare I · bipolare II · ciclotimico · rimuginio ·  
ruminazione · DAG · attacco di panico · nevrosi · egodistonico ·  
egosintonico · struttura nevrotica · scompenso · esame di realtà  
· ossessioni · compulsioni · sollievo vs. piacere · conversione ·  
isteria · DOC · conflitto edipico · temperamento · carattere ·  
personalità · tratto · stato · goodness of fit · diatesi · corazza  
caratteriale · egosintonia · diffusione dell'identità ·  
organizzazione borderline · cluster A/B/C · BPD · DBT · Big Five ·  
PDM-2 · psicosi · organica · funzionale · io-qui-adesso ·  
dissociazione schizofrenica · delirio · autismo schizofrenico ·  
depersonalizzazione · derealizzazione · sintomi positivi ·  
sintomi negativi · disorganizzazione · tipo 1 · tipo 2 · delirium  
tremens · Korsakov · epilessia · crisi pantoclastica ·  
angoscia di frammentazione · premorboso · prodromico · Körper ·  
Leib · sessualità · identità di genere · orientamento sessuale ·  
sesso biologico · cisgender · transgender · gender fluid ·  
agender · intersex · AFAB · AMAB · disforia di genere · parafilia ·  
disturbo parafilico · bisogno vs. desiderio · snodi di Lalli ·  
compulsività · asfissiofilia · frotteurismo · voyeurismo ·  
esibizionismo

---

## Filo conduttore

Si parte chiedendo cosa sia la salute e si scopre subito che non c'è una risposta unica: salute, malattia, normalità e benessere sono costrutti che non coincidono mai del tutto (Lez. 01). La storia della follia mostra che la psichiatria ha sempre oscillato tra due paradigmi — organico e passionale — e che ogni epoca ha riscritto il confine tra ciò che è curabile e ciò che non lo è (Lez. 02). Per stare davvero accanto a chi soffre servono strumenti: l'empatia nelle sue diverse forme e con i suoi bias (Lez. 03); la capacità di leggere le emozioni e le difese che il soggetto mette in campo contro l'angoscia (Lez. 04); una semiologia precisa per osservare comportamento, coscienza, memoria, percezione (Lez. 05). Con questi strumenti si arriva ai grandi quadri clinici: dalle sindromi affettive e ansiose (Lez. 06) alle nevrosi — dove il

conflitto è ancora egodistonico e l'esame di realtà mantenuto (Lez. 07) — fino ai disturbi di personalità, dove i tratti rigidi sono egosintonici e la sofferenza spesso ricade sugli altri (Lez. 08), e alle psicosi, dove il rapporto con la realtà si rompe o si dissocia in modo radicale (Lez. 09). La traiettoria è un continuum: non categorie stagno, ma gradi crescenti di compromissione dell'identità, della relazione con l'altro e del contatto con il reale. Il modulo apre poi una seconda finestra sull'identità attraverso il corpo sessuato (Lez. 10): la sessualità come sviluppo relazionale, il passaggio evolutivo dal bisogno al desiderio, la distinzione tra parafilia e disturbo parafilico e il tema della disforia di genere — dove ancora una volta il punto non è la condizione ma la sofferenza che essa genera. Il filo rosso, ribadito da Cargnello fin dall'inizio, resta uno solo: la clinica è l'incontro con qualcuno, mai la gestione di qualcosa.